용혈 + 혈소판감소 TMA 의심은 응급 의뢰

Thrombotic microangiopathy · TTP/HUS를 놓치지 않기

용혈 소견 → PBS·혈소판 확인

↓

Schistocyte + 혈소판감소

↓

신기능 저하·신경 증상·혈전증
TMA 의심 → 응급 혈액내과 의뢰

용혈의 검사 소견

구분	진료 중 확인할 내용
주요 소견	Reticulocyte↑ · LDH↑ · haptoglobin↓ · 간접 bilirubin↑. 주로 대구성 빈혈 형태.
추가 확인	말초혈액도말(PBS)의 schistocyte, Direct Coombs test, PNH 등.

원인 병력 · 면역성/비면역성 용혈

구분	진료 중 확인할 내용
기계적 용혈 단서	심장판막질환·판막수술 병력. 좁은 판막을 통과하며 적혈구가 깨질 수 있음.
면역성 원인 단서	자가면역질환, 최근 약물, 감염력.

! 세 소견이 함께 보이면 TTP/HUS 고려

미세혈관병성 용혈성 빈혈(MAHA), 혈소판감소, 장기기능 이상(혈전증)의 조합을 봅니다. PBS의 schistocyte와 혈소판감소에 질소혈증·신기능 저하, 신경학적 증상 또는 혈전증이 동반되면 응급으로 혈액내과에 의뢰합니다.

함께 보는 혈액내과 의뢰 소견

말초혈액의 blast·immature cell(백적혈모구성 반응 포함), Hb가 빠르게 감소하는 경과, 백혈구·혈소판 이상 동반, 원인 불명 빈혈도 혈액내과 의뢰 대상입니다.